

Módulo 2 — MFC | Medicina de Família e Comunidade

Concurso Médico IBAM | Praia Grande 001/2026 | Atualizado mai/2026

SUMÁRIO

- 1. Guia Estratégico
- 2. MFC — Conceitos e Atributos (Starfield)
- 3. Abordagem Centrada na Pessoa
- 4. Processo de Trabalho na APS
- 5. Ética Médica, Sigilo e Prontuário
- 6. Biossegurança e Segurança do Paciente
- 7. Calendário Vacinal 2026 (PNI atualizado)
- 8. Saúde da Criança — Puericultura e Triagem Neonatal
- 9. Saúde da Mulher — Pré-natal e Planejamento Reprodutivo
- 10. Rastreamento de Cânceres — Colo Útero (2025) e Mama (2025)
- 11. HAS — Diretriz SBC 2025
- 12. Diabetes Mellitus — Diretriz SBD 2024-2025
- 13. Saúde do Adulto e do Idoso
- 14. Saúde Mental na APS
- 15. Demanda Programada/Espontânea e Visita Domiciliar
- 16. Cuidado Compartilhado e Apoio Matricial
- 17. Grupos Prioritários e Vulneráveis
- 18. Educação em Saúde
- 19. Pegadinhas Clássicas IBAM (25)
- 20. Questões de Revisão Comentadas (18)

1. GUIA ESTRATÉGICO — MÓDULO 2

Área SUS/Saúde Coletiva (Módulo 1)	Questões 20	Peso 2	Pontos 40	Prioridade IIIII
Específicos MFC (ESTE módulo)	10	3	30	IIII — maior peso/ questão
Língua Portuguesa	10	1	10	III

ESTRATÉGIA

Cada questão aqui vale 3 pts — errar uma dói mais que errar no SUS.

O IBAM cobra CONCEITOS e DEFINIÇÕES — não casos clínicos complexos.

Foco máximo: atributos Starfield, rastreamentos (mudanças 2025!), calendário vacinal, HAS e DM.

Tema Atributos APS — Starfield (4 essenciais + 3 derivados)	Frequência IBAM Alta	Novidade 2025 Não
Rastreamento colo útero — DNA-HPV como 1ª linhaAlta		SIM — crítico
Rastreamento mama — 40 a 74 anos	Alta	SIM — Lei 15.284/2025
HAS — Diretriz SBC 2025 (pré-hipertensão nova)	Alta	SIM
DM — Diretriz SBD 2024-2025 (TOTG-1h)	Alta	SIM
Calendário vacinal — vacina VSR gestante	Alta	SIM
Processo de trabalho APS / acolhimento / demandaMédia-Alta		Não
		Não

Tema Atributos APS — Starfield (4 essenciais + 3 derivados)	Frequência IBAM Alta	Novidade 2025 Não
Saúde da criança — puericultura / 4 testes neonatosMédia-Alta		
Saúde mental na APS — o que tratar vs encaminharMédia		Não
Grupos vulneráveis — políticas	Média	Não

2. MEDICINA DE FAMÍLIA — CONCEITOS E ATRIBUTOS DA APS

(Starfield)

2.1 Definição da Especialidade:

A MFC provê atenção continuada, integral e centrada na pessoa, à família e à comunidade. O médico de família cuida de PESSOAS — não de órgãos isolados — em todas as fases da vida.

Atributo Primeiro Contato	Tipo ESSENCIAL	Definição APS = porta de entrada PREFERENCIAL	Pegadinha do A sistema prova diz para "qualquer novos problemas serviço" → INCOMPLETO
Longitudinalidade	ESSENCIAL	Vínculo contínuo profissional-paciente ao longo	seguimento do tempo — de mesmo doença sem crônica. doença Inclui pacientes ≠
Integralidade	ESSENCIAL	Conjunto articulado: promoção + prevenção	≠ + resolver diagnóstico tudo + na tratamento APS. É OFERECER + reabilitação o conjunto
Coordenação do Cuidado	ESSENCIAL	APS organiza o cuidado ao longo dos pontos	A da prova rede coloca — referência no hospital e contrarreferência → ERRADO. É função
Orientação Familiar	DERIVADO	Família como unidade de cuidado — genograma,	Derivado APGAR = fortalece familiar a APS; não existe em todo sistema
Orientação Comunitária	DERIVADO	Conhecer e usar os recursos da comunidade	Idem — território, ACS, PSE
Competência Cultural	DERIVADO	Adaptar cuidado à diversidade étnica, cultural	Respeito e social ao da nome população social, adscrita cuidado indígena adequado

I MACETE — Atributos

4 ESSENCIAIS = PLIC: Primeiro contato | Longitudinalidade | Integralidade | Coordenação
3 DERIVADOS: Orientação Familiar | Orientação Comunitária | Competência Cultural
Essenciais = existem em qualquer APS de qualidade. Derivados = qualificam ainda mais.

I PEGADINHAS — Atributos

Longitudinalidade ≠ continuidade de tratamento. Vínculo inclui paciente SAUDÁVEL.
Integralidade ≠ resolver tudo na APS. É oferecer o conjunto e coordenar o restante.
São 4 essenciais — a prova cita 3 omitindo Coordenação ou coloca 5.

3. ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA, FAMÍLIA E COMUNIDADE

Componente S — Subjetivo	O que registra Queixa principal, história da doença, medicamentos em uso, alergias — o que o paciente relata
O — Objetivo	Sinais vitais, exame físico, resultados de exames — o que o profissional observa
A — Avaliação	Hipóteses diagnósticas, diagnósticos, problemas identificados — raciocínio clínico
P — Plano	Conduta: exames, prescrições, orientações, encaminhamentos, retorno

Ferramenta Genograma	Descrição Representação gráfica da família em ≥3 gerações. Identifica padrões de doença e dinâmica. I = homem, I
Ecomapa	Relações da família com ambiente externo: trabalho, amigos, serviços, comunidade
APGAR Familiar	5 itens (0-2 cada): Adaptação Participação Crescimento (Growth) Afeto Resolução. 0-3=disfunção grave;
Ciclo de vida familiar	Estágios: formação filhos pequenos adolescentes ninho vazio velhice. Crises normativas em cada → → → →

APGAR Familiar — cobrado pelo IBAM

A = Adaptação | P = Participação | G = Growth (Crescimento) | A = Afeto | R = Resolução
Pontuação: cada item 0 (nunca), 1 (às vezes), 2 (sempre). Total 0-10.
Mnêmico: "APGAR" — igual ao Apgar do RN mas para a família.

Modelo Biomédico	Foco Doença como problema biológico isolado	Base Apenas biologia — ignora psique e contexto social
Biopsicossocial (MFC)	Pessoa em seu contexto: corpo + mente + relações sociais	Bio + Psico + Social — base epistemológica da MFC

4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS

Tipo Programada	Definição Consultas agendadas — condições	Exemplos Retorno crônicas, HAS/DM, programas pré-natal, preventivos puericultura,	Organização 60-70% idosos da agenda. frágeis Blocos por programa.
Espontânea	Queixas agudas, sem agendamento	Febre, prévio lombalgia súbita, ansiedade	aguda, 20-30% infecção da agenda. urinária Acolhimento com classificação
Visita domiciliar	Cuidado no território	Acamados, RN, puérperas, saúde	mental ~10% da agenda

4.2 Acolhimento:

Postura ética de ESCUTA QUALIFICADA adotada por TODOS os profissionais em TODOS os momentos. Não é triagem. Não é sala de espera. Implica receber, ouvir, responsabilizar e direcionar.

Cor Vermelho — Emergência	Prazo Imediata	Conduta Estabilização + SAMU ou transferência imediata
Laranja — Urgência	≤15 min	Atendimento médico breve; monitorar
Amarelo — Pouco urgente	≤30-60 min	Atendimento na sessão, pode aguardar
Verde — Não urgente	≤120 min	Pode ser agendado ou atendido na sessão

Cor Vermelho — Emergência	Prazo Imediata	Conduta Estabilização + SAMU ou transferência imediata
Azul — Eletivo	Agendamento	Orientação e consulta programada

I PEGADINHAS — Processo de Trabalho

Acolhimento ≠ triagem. Triagem = separar/filtrar. Acolhimento = escuta e responsabilização de TODOS.

"Agenda fechada" não existe no SUS — UBS sempre avalia quem chega com demanda.

Coordenação do cuidado é da APS — não do hospital nem do especialista.

5. ÉTICA MÉDICA, SIGILO, PRONTUÁRIO E CONSENTIMENTO

Ponto Atos privativos	Regra Diagnóstico, prescrição, solicitação de exames, alta/ internação, atestados, laudos, declaração de óbito
Direção técnica	Chefia imediata de serviço de saúde = privativo do médico
Emergência	Médico NUNCA pode recusar atendimento em emergência — mesmo em consultório particular
Declaração de óbito	Médico assistente emite. SVO: quando não havia médico assistente. IML: suspeita de morte violenta

Tema Sigilo profissional	Regra Dever de manter sigilo das informações do	Exceção / Pegadinha paciente Exceções (Art. legais: 73) notificação compulsória, proteção de terceiros,
Notificação compulsória	DEVER do médico — mesmo sem autorização	NÃO do viola paciente sigilo. É exceção prevista em lei.
Consentimento informado	Esclarecer sobre diagnóstico, tratamento,	riscos, Paciente alternativas, CAPAZ pode prognóstico RECUSAR tratamento — mesmo com risco
Prontuário	Obrigatório. Prazo mínimo: 20 anos. Pertence	Serviço MORALMENTE guarda, paciente ao PACIENTE. acessa. A prova diz "pertence ao médico"
Telemedicina	Permitida — Resolução CFM 2.314/2022.	Exige A prova sigilo pode e qualidade. negar sua legalidade → ERRADO.

6. BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA DO PACIENTE

Grupo A	Tipo Biológico	Exemplos Sangue, secreções, curativo, placenta	Descarte Saco branco leitoso → autoclave
B	Químico	Medicamentos vencidos, reagentes, mercúrio	Saco laranja ou recipiente específico
C	Radioativo	Radiofármacos	Recipiente com símbolo de radioatividade
D	Comum	Papéis, embalagens do refeitório	Saco preto — lixo comum
E	Perfurocortante	Agulhas, lâminas, bisturis	Caixa amarela rígida (descarpak) — NUNCA no lixo comum

I MACETE — RSS

A=biológico | B=químico | C=radioativo | D=doméstico(comum) | E=perfurocortante(agulha)

Agulha → SEMPRE caixa amarela (E). Nunca na lixeira comum.

Meta 1. Identificar o paciente	Descrição ≥2 identificadores: nome + data de nascimento	Na APS Conferir antes de vacinar ou medicar
2. Comunicação efetiva	Passagem de casos clara — ISBAR	Carta de referência completa; prontuário legível
3. Medicamentos seguros	Alta vigilância: insulina, anticoagulantes,	Conferir eletrólitos dose e via antes de injeções na UBS
4. Cirurgia segura	Checklist OMS	Procedimentos menores (sutura) — técnica asséptica
5. Higienizar as mãos	5 momentos da OMS — principal medida	Obrigatória anti-infecciosa antes e após todo atendimento
6. Reduzir quedas/UP	Escala de Braden; avaliar risco de queda	Visita em idosos domiciliar: ambiente seguro para o idoso

5 Momentos da Higienização das Mãos

- ANTES de tocar o paciente | 2. ANTES de procedimento asséptico
- APÓS risco de exposição a fluidos | 4. APÓS tocar o paciente
- APÓS tocar superfícies próximas ao paciente

7. CALENDÁRIO VACINAL 2026 — PNI (INSTRUÇÃO NORMATIVA

CNV 2026 — ATUALIZADO 30/01/2026)

NOVA VACINA 2025-2026 — VSR PARA GESTANTE

Vacina VSR (Vírus Sincicial Respiratório): 1 dose a partir da 28ª semana, em CADA gestação.

Objetivo: proteger o RN contra bronquiolite e pneumonia por VSR — principal causa de hospitalização em lactentes.

Anticorpo Nirsevimabe: alternativa para RN cujas mães não foram vacinadas.

Idade Ao nascer (12-24h)	Vacinas BCG dose única + HepB 1ª	Observação Crítica BCG = dose única, sem reforço. HepB = obrigatória antes da alta.
2 meses	Pentavalente 1ª + VIP 1ª + Rotavírus 1ª + Pneumo10	Rotavírus: 1ª JANELA — 1ª dose até 3m7d. Fora da janela = NÃO
3 meses	MenC 1ª	Esquema MenC: 3-5-12 meses
4 meses	Pentavalente 2ª + VIP 2ª + Rotavírus 2ª + Pneumo10	Rotavírus: 2ª 2ª e ÚLTIMA dose — janela até 7m29d
5 meses	MenC 2ª	
6 meses	Pentavalente 3ª + VIP 3ª + Influenza	Influenza: anual. 1ª vez (<9 anos): 2 doses com 30d de intervalo
9 meses	Febre Amarela 1ª dose	Antecipar 6-8 meses SOMENTE em área de risco com transmissão
12 meses	Pneumo10 reforço + MenC reforço + SCR + HepA	SCR 1ª = Sarampo + Caxumba + Rubéola
15 meses	DTP reforço + VOP reforço + Varicela (SCRv/Tetraviral)	DTP = 1º + reforço HepA 2ª
4 anos	DTP 2º reforço + VOP 2º reforço + FA reforço	FA: após 5 anos → dose ÚNICA vitalícia
9 anos	HPV 4v (1 dose) — meninas E meninos	

Idade Ao nascer (12-24h)	Vacinas BCG dose única + HepB 1ª	Observação Crítica BCG = dose única, sem reforço. HepB = obrigatória antes da alta.
		9-14a: dose única. ≥15a: 2 doses. Imunodeprimidos: 3 doses.
COVID-19	Disponível a partir de 6 meses	Esquema conforme recomendação vigente

I PEGADINHAS — Calendário da Criança

BCG: dose ÚNICA — sem reforço. FA: 1ª dose 9m, reforço 4a. Após 5 anos: dose única vitalícia.

Rotavírus: JANELA RÍGIDA. 1ª até 3m7d. 2ª até 7m29d. Não vacinar fora do prazo.

HPV: dose única para 9-14 anos (meninas E meninos). ≥15a: 2 doses.

Influenza: anual. Primeira vez (<9a): 2 doses com 30 dias de intervalo.

Vacina dTpa	Esquema 1 dose em CADA gestação — 27ª-36ª	Observação semana Protege (pode RN contra ser da coqueluche. 20ª semana) OBRIGATÓRIA em cada gestação.
Influenza	1 dose em qualquer trimestre — anual	Protege gestante e RN
Hepatite B	3 doses se não vacinada	Se já vacinada: não repetir
COVID-19	Manter esquema atualizado	Segura em todos os trimestres
VSR	1 dose a partir da 28ª semana, em CADA	NOVA gestação 2025-2026. Protege RN de VSR.
Febre Amarela	CONTRAINDICADA (vírus vivo)	Excepcionalmente: surto com risco real — avaliar após 1º trimestre
SCR / Varicela	CONTRAINDICADAS (vírus vivos)	Administrar no puerpério imediato se não vacinada

I PEGADINHAS — Gestante

dTpa: em CADA gestação, não apenas na primeira.

Febre Amarela: CONTRAINDICADA. Vírus vivo. A prova tenta colocar como obrigatória → ERRADO.

VSR: nova vacina — não estava em provas anteriores.

Vacina dT	Adulto (20-59a) Reforço a cada 10 anos	Idoso (≥60a) Reforço a cada 10 anos
dTpa	1 dose em substituição ao dT (convive	com 1 dose RN/gestante) se nunca recebeu
Influenza	Grupos de risco (gestante, prof. saúde,	comorbidades) Anual — OBRIGATÓRIA nas campanhas
HepB	3 doses se não vacinado	3 doses se não vacinado
Febre Amarela	1 dose única vitalícia (se área de risco)	Avaliar risco-benefício ≥60a
Pneumo23	Não rotineira para saudável	Acamados/institucionalizados: 2 doses, intervalo 5 anos

8. SAÚDE DA CRIANÇA — PUERICULTURA E TRIAGEM NEONATAL

Faixa Etária RN 0-28 dias	Frequência 1ª consulta até 7 dias	Foco (ideal Aleitamento, 3-5 dias) triagem neonatal, icterícia, coto umbilical, vínculo
1-6 meses	Mensalmente	Crescimento, desenvolvimento, vacinação, aleitamento exclusivo
6-12 meses	A cada 2 meses	

Faixa Etária RN 0-28 dias	Frequência 1ª consulta até 7 dias	Foco (ideal Aleitamento, 3-5 dias) triagem neonatal, icterícia, coto umbilical, vínculo
		Introdução alimentar, marcos de desenvolvimento
1-2 anos	A cada 3 meses	Linguagem, marcha, desenvolvimento cognitivo
2-6 anos	A cada 6 meses	Saúde bucal, visão, audição
6-10 anos	Anual	Saúde escolar, crescimento, puberdade

Teste Pezinho	Prazo Ideal 3-5 dias de vida (até 30	O que Detecta PKU, dias) Hipotireoidismo, Falciforme, Fibrose	Detalhe Crítico Colher Cística, após Hiperplasia 24h de leite Adrenal materno. Pode
Orelhinha	Antes da alta (até 1 mês)Perda	auditiva congênita	Obrigatória em hospitais com >500 partos/ano.
Olhinho (Reflexo Vermelho)	Na maternidade ou 1ª	consulta Catarata, glaucoma, retinoblastoma	Reflexo ausente = encaminhar URGENTE
Coraçãozinho (Oximetria)	24-48h de vida	Cardiopatia congênita crítica	SpO2 ≥95% em MSD e MMII. Diferença
Linguinha	Antes da alta (complementar)	Anquiloglossia (freio curto)	Protocolo PIBF. Pode ser feito por enfermeiro

Marcos de Desenvolvimento Motor — Referência Rápida

2m: sustenta cabeça em pronação | 4m: rola prono → supino | 6m: senta com apoio
9m: engatinha, pinça inferior, senta sem apoio | 12m: fica em pé, 1-3 palavras
18m: anda bem, torre de 3 cubos | 24m: corre, frases de 2 palavras

Aspecto Exclusivo	Recomendação Oficial (OMS + MS) Apenas leite materno até 6 meses — sem água, chá ou qualquer outro alimento
Complementado	Leite materno + alimentação complementar de 6 meses até 2 anos ou mais
Introdução alimentar	A partir de 6 meses completos — frutas, legumes, cereais, carnes
Contraindicações	HIV materno, HTLV, galactosemia no lactente, drogas ilícitas
HBsAg positivo	NÃO contraindica AM se RN recebeu imunoglobulina + HepB nas primeiras 12h

9. SAÚDE DA MULHER — PRÉ-NATAL E PLANEJAMENTO

REPRODUTIVO

Aspecto Início	Recomendação MS Até 12 semanas (1º tri). Ideal: até 120 dias (4 meses).
Nº mínimo de consultas	6 (SUS: PHPN). OMS recomenda ≥8. — 1º tri: 1 2º tri: 2 3º tri: 3
Exames obrigatórios	Tipagem + Rh VDRL Anti-HIV HBsAg Urina I Glicemia jejum Hemograma Toxoplasmose IgM/IgG
VDRL	1º trimestre + 3º trimestre + no parto
Anti-HIV	1º e 3º trimestres — prevenção transmissão vertical
USG	Idealmente até 14 semanas para datação

Aspecto Início	Recomendação MS Até 12 semanas (1º tri). Ideal: até 120 dias (4 meses).
Vinculação à maternidade	Gestante deve conhecer a maternidade de referência antes do parto
Alto risco	Idade <16 ou >35a, gemelar, HAS, DM, cardiopatia, pré-eclâmpsia prévia → REFERENCIAR

I PEGADINHAS — Pré-natal

VDRL: 1º tri + 3º tri + parto. Não é apenas 1 vez.

Anti-HIV: 1º e 3º trimestres — rastreio do binômio.

Rubéola: NÃO vacinar na gestação (vírus vivo). Rastrear; vacinar no puerpério.

HBsAg positivo: NÃO contraindica AM (diferente do HIV).

Método Preservativo masculino	Eficácia Típica ~85%	Na APS Único que protege contra IST. Sempre recomendar.
COC (pílula combinada)	~91%	1ª linha sem contraindicações. CI: HAS grave, migrânea com aura, tabagismo
Minipílula (progestágeno)	~91%	Puérpera amamentando, CI ao estrogênio.
Injetável trimestral (Depo-Provera)	~94%	Retorno da fertilidade: até 18 meses.
DIU de cobre	>99%	Muito eficaz, não hormonal, reversível. Disponível no SUS. 10 anos.
DIU hormonal (Mirena)	>99%	Reduz fluxo. 5 anos. Pode tratar endometriose.
Laqueadura	>99%	Permanente. Consentimento livre e informado. SUS oferece.
Vasectomia	>99%	Mais simples que laqueadura. SUS oferece.

10. RASTREAMENTO DE CÂNCERES NA APS — DIRETRIZES

ATUALIZADAS 2025

MUDANÇAS CRÍTICAS 2025 — ALTÍSSIMA PROBABILIDADE DE CAIR NA PROVA

Colo do útero: DNA-HPV SUBSTITUI Papanicolau como método PRIMÁRIO (Portaria SAES/SECTICS 13/2025).

Mama: faixa etária AMPLIADA para 40-74 anos (Lei 15.284/2025).

10.1 Câncer do Colo do Útero — Nova Diretriz 2025:

Portaria SAES/SECTICS 13/2025 — MUDANÇA PRINCIPAL

ANTES (até 2024): Papanicolau como método primário, a cada 3 anos, 25-64 anos.

AGORA: DNA-HPV oncogênico = MÉTODO PRIMÁRIO. Papanicolau = exame REFLEXO (secundário).

Transição gradual: onde não há DNA-HPV disponível, Papanicolau continua sendo usado.

Aspecto Método primário	Modelo Anterior (Papanicolau) Papanicolau (citologia)	Modelo Atual 2025 (DNA-HPV) DNA-HPV oncogênico
Faixa etária	25-64 anos	25-64 anos (igual)
Intervalo	A cada 3 anos	A cada 5 anos se negativo
HPV 16 ou 18 positivo	Não se aplicava	→ Colposcopia DIRETA

Aspecto Método primário	Modelo Anterior (Papanicolau) Papanicolau (citologia)	Modelo Atual 2025 (DNA-HPV) DNA-HPV oncogênico
Outros tipos oncogênicos	Não se aplicava	→ Citologia reflexa na mesma amostra
DNA-HPV negativo	Não se aplicava	→ Repetir em 5 anos
Papanicolau agora	Método primário	Exame reflexo apenas em casos específicos

I PEGADINHAS — Colo do Útero

Antes de 25 anos: NÃO rastrear (alta regressão espontânea).

Após 64 anos com 2 exames negativos nos últimos 5 anos: ENCERRAR.

HPV 16/18 = colposcopia DIRETA — não esperar citologia.

DNA-HPV negativo = repetir em 5 ANOS (não 3 anos, não 1 ano).

10.2 Câncer de Mama — Lei 15.284/2025:

Lei 15.284/2025 + Nota Técnica INCA 626/2025

ANTES (até set/2025): rastreamento bienal para 50-69 anos.

40-49 anos: acesso GARANTIDO à mamografia por DECISÃO COMPARTILHADA médico-paciente.

50-74 anos: rastreamento BIENAL ATIVO (ampliado de 69 para 74 anos).

Acima de 74 anos: decisão INDIVIDUALIZADA.

Faixa Etária < 40 anos	Conduta 2025 Apenas com fatores de risco elevado (BRCA, familiar 1º	Periodicidade Individual grau) — pode ser anual com RM
40-49 anos	Acesso garantido por decisão compartilhada (Lei 15.284/2025)	Bienal se optar
50-74 anos	Rastreamento bienal ATIVO (INCA/MS)	A cada 2 anos
≥75 anos	Decisão individualizada	Conforme caso clínico

I PEGADINHAS — Mama

"Rastreamento para 50 a 69 anos" → DESATUALIZADO. Agora: 50-74 anos (ativo) + 40-49 (decisão compartilhada).

"Mamografia anual" → ERRADO. É bienal (a cada 2 anos).

INCA e Lei 15.284 não são contraditórios: INCA prioriza 50-74; Lei garante ACESSO a partir dos 40.

Câncer Colorretal	Recomendação PSOF anual + colonoscopia a cada 10 anos	Quem / Quando Homens e mulheres ≥50 anos, risco médio
Próstata	PSA + toque retal — DECISÃO COMPARTILHADA.	Homens Não é universal. ≥50a (45a se negro ou familiar 1º grau)
Pulmão	TC de baixa dose — apenas tabagistas alto risco	≥50a, ≥20 maços-ano, fumante atual ou parou <15a
Pele	Exame oportunístico — sem rastreamento formal no	Especialmente SUS fotoexpostos — orientar protetor solar

11. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA — DIRETRIZ SBC 2025

ATUALIZAÇÃO CRÍTICA — Diretriz HAS SBC 2025

NOVA CATEGORIA: Pré-hipertensão = PAS 120-139 mmHg E/OU PAD 80-89 mmHg.

PA Normal AGORA: PAS <120 E PAD <80. (Antes: 120/80 era "ótima" — categoria extinta).

1ª diretriz com capítulo sobre HAS NA APS e HAS EM MULHERES.

Classificação SBC 2025 PA Normal	PAS (mmHg) < 120	PAD (mmHg) < 80	Conduta Reavaliar anualmente
Pré-hipertensão (NOVA)	120-139	80-89	MEV. MAPA/MRPA se suspeita de hipertensão mascarada.
HAS Estágio 1	140-159	90-99	Confirmar + MEV ± fármaco conforme risco CV
HAS Estágio 2	160-179	100-109	MEV + tratamento farmacológico
HAS Estágio 3	≥ 180	≥ 110	Tratamento imediato
Urgência hipertensiva	≥ 180/120 SEM lesão	órgão-alvo	Reduzir PA em horas. Medicação oral.
Emergência hipertensiva	≥ 180/120 COM lesão	órgão-alvo	Internação. Reduzir PA em minutos. Via IV.

Aspecto Diagnóstico	Detalhe — Diretriz SBC 2025 ≥140/90 em consultório. ≥2 medidas/consulta, ≥2 consultas em dias diferentes (ou MAPA/MRPA)
MAPA	Padrão ouro 24h. Identifica avental branco, mascarada, hipertensão noturna
HAS avental branco	Alta no consultório, normal fora (MAPA normal). NÃO é HAS — mas tem risco aumentado
HAS mascarada	Normal no consultório, alta fora (MAPA alterado). É HAS — tratar
Meta geral	< 140/90 mmHg para maioria
Meta alto risco CV	< 130/80 — DCV estabelecida, DM, DRC, risco CV ≥20%
1ª linha farmacológica	IECA ou BRA + BCC (bloqueador canal de cálcio) + Diurético tiazídico — qualquer dos 3
HAS na gestante	CONTRAINDICADOS: IECA e BRA. Usar: metildopa (1ª linha), nifedipino, hidralazina
Mudança estilo de vida	Sódio <2g/dia, dieta DASH, exercício, perda de peso, redução álcool, cessação tabagismo

I PEGADINHAS — HAS

120/80 = PA Normal. 120-139/80-89 = Pré-hipertensão (nova). ≥140/90 = HAS.

IECA e BRA: CONTRAINDICADOS na gestação. A prova inclui como opção para gestante → ERRADO.

Urgência = sem lesão órgão-alvo. Emergência = COM lesão. A prova confunde.

Diagnóstico: não em uma medida isolada. Requer confirmação.

12. DIABETES MELLITUS — DIRETRIZ SBD 2024-2025

ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA — Diretriz SBD 2024

NOVO CRITÉRIO: TOTG-1h — glicemia 1 hora após 75g de glicose.

≥155 mg/dL = pré-diabetes. ≥210 mg/dL = diabetes mellitus.

Os critérios tradicionais (GJ, HbA1c, TOTG-2h) permanecem igualmente válidos.

MUDANÇA TERAPÊUTICA SBD 2025: metformina não é mais a 1ª linha universal para todo DM2.

Critério Diagnóstico Glicemia de jejum (8h)	Pré-diabetes 100-125 mg/dL	Diabetes ≥ 126 mg/dL
HbA1c	5,7% - 6,4%	≥ 6,5%
TOTG-2h (75g glicose)	140-199 mg/dL	200 mg/dL ≥

Critério Diagnóstico Glicemia de jejum (8h)	Pré-diabetes 100-125 mg/dL	Diabetes ≥ 126 mg/dL
TOTG-1h (NOVO SBD 2024)	155-209 mg/dL	≥ 210 mg/dL
Glicemia casual + sintomas	—	≥ 200 mg/dL com poliúria/polidipsia/perda de peso

Aspecto Terapêutico Rastreamento APS	Diretriz SBD 2025 FINDRISC para estratificar risco. GJ em adultos com risco moderado-alto.
Lógica terapêutica	Escolha INDIVIDUALIZADA — não mais metformina universal. Considerar: risco CV, peso, função
Alto/muito alto risco CV	Preferir inibidor SGLT2 (empagliflozina) ou agonista GLP-1 (semaglutida) — com ou sem metformina
Obesidade predominante	Preferir agonista GLP-1 — redução ponderal + controle glicêmico
Sem comorbidades / baixo risco	Metformina ainda é opção válida, acessível e disponível no SUS
Meta HbA1c geral	< 7%. Individualizar: <6,5% jovens; 7-8% idosos frágeis ou com risco de hipoglicemia
Insulina	DM1; HbA1c>9% com sintomas; falha de hipoglicemiantes orais
Pé diabético	Examinar pés em TODA consulta. Monofilamento 10g. Cuidados diários

I PEGADINHAS — DM

Metformina não é mais universal para todo DM2. Alto risco CV: preferir SGLT2 ou GLP-1.
TOTG-1h: critério NOVO 2024. ≥155 = pré-DM. ≥210 = DM.
DM gestacional: GJ ≥92 mg/dL em qualquer momento, ou TOTG 100g às 24-28 semanas.

13. SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Condição HAS	Método Medição da PA	Quem ≥18 anos	Periodicidade ≥1 vez/ano. Anual se pré-HT.
DM2	GJ ou HbA1c	≥35a com fatores de risco	A cada 3 anos se normal
Dislipidemia	Perfil lipídico	Homens ≥35a; mulheres ≥45a	A cada 5 anos se normal
Colo útero	DNA-HPV (novo 2025)	25-64 anos	A cada 5 anos se negativo
Mama	Mamografia	40-74 anos (nova faixa 2025)Bienal	
Colorretal	PSOF + colonoscopia	≥50 anos	PSOF anual; colonoscopia 10/10 anos
Depressão	PHQ-2 / PHQ-9	Adultos com fatores de riscoTriagem	em consultas de rotina
HIV	Testagem	15-64 anos	Pelo menos 1 vez; repetir com exposição
Osteoporose	Densitometria (DXA)	Mulheres ≥65a; homens ≥70a	A cada 2-5 anos

Domínio Cognitivo	Ferramenta na APS MEEM (Mini Exame do Estado Mental), Teste do Relógio, MoCA
ABVD (Atividades Básicas de Vida Diária)	Índice de Katz: banho, vestir, higiene, transferência, continência, alimentação
AIVD (Atividades Instrumentais)	Escala de Lawton: cozinhar, finanças, transporte, medicamentos, compras

Domínio Cognitivo	Ferramenta na APS MEEM (Mini Exame do Estado Mental), Teste do Relógio, MoCA
Mobilidade e quedas	TUG (Timed Up and Go), Velocidade de Marcha
Nutricional	MNA (Mini Nutritional Assessment)
Humor / Depressão	GDS-15 (Geriatric Depression Scale)
Polifarmácia (≥5 medicamentos)	Revisão e reconciliação medicamentosa em toda consulta
Contexto social	Mora sozinho? Tem cuidador? Isolamento? Violência?

Síndromes Geriátricas — 8Ps

Polifarmácia | Perda de peso | Perda de memória | Perda de mobilidade (quedas)
Poliúria/incontinência | Pressão (escaras) | Perda sensorial | Problemas emocionais

14. SAÚDE MENTAL NA APS

Na APS — Manejar Depressão leve a moderada (PHQ-9 <15)	No CAPS — Encaminhar Depressão grave / com psicose / risco de suicídio alto
Ansiedade leve a moderada (GAD-7 <15)	Episódio maniaco agudo
Sofrimento mental comum, luto, insônia	Psicose ativa (esquizofrenia em crise)
TM crônico ESTABILIZADO	Dependência química grave — síndrome de abstinência
Uso não problemático de álcool/SPA	Automutilação grave ou recente
Acompanhamento pós-estabilização	TM grave descompensado

Risco de Suicídio na APS

Perguntar sobre suicídio NÃO aumenta o risco — acolhe e diminui.
Avaliar: frequência, plano, intenção, meios disponíveis, fatores protetores.
Risco alto: CAPS urgente ou PS. Não deixar sozinho.
Orientar remoção de meios letais do domicílio.

Ferramenta PHQ-2	Uso Triagem rápida depressão (2 perguntas)Total	Interpretação ≥3: aplicar PHQ-9 completo
PHQ-9	Diagnóstico e monitoramento depressão	0-4 (9 itens, sem 0-27) 5-9 leve 10-14 moderada 15-19 mod-grave ≥20 grave
GAD-7	Triagem de ansiedade generalizada (7	itens, ≥10: provável 0-21) TAG — tratar ou encaminhar
AUDIT-C	Triagem uso de risco de álcool (3 itens)	≥4 mulheres / ≥5 homens: uso de risco
Condição Depressão moderada	1ª Linha ISRS: fluoxetina 20mg/dia ou sertralina 50mg/diaFluoxetina	No SUS e sertralina na RENAME
Ansiedade generalizada	ISRS (mesmos da depressão)	Sim
Insônia	Higiene do sono + TCC. Evitar BZD longa duração.	Zolpidem: com cautela, prazo limitado
Bipolar estabilizado	Lítio ou valproato	Lítio disponível no SUS

15. DEMANDA PROGRAMADA/ESPONTÂNEA E VISITA DOMICILIAR

Tipo Consultas programadas	% da Agenda 60-70%	Composição Crônicos (HAS, DM), pré-natal, puericultura, idosos frágeis, prevenção
----------------------------	--------------------	---

Demanda espontânea	20-30%	Queixas agudas com acolhimento e classificação de risco
Visitas domiciliares	~10%	Acamados, RN, puérpera, saúde mental, idosos frágeis
Atividades coletivas	Variável	Grupos de HAS/DM, gestantes, idosos, PSE

Indicação Paciente acamado / limitação de mobilidade	Responsável Equipe de saúde (médico + enfermeiro)
RN (1ª VD até 7 dias de vida) / Puérpera	Enfermeiro ± médico
Saúde mental — difícil acesso / recusa à UBS	Equipe de saúde ± matriciamento CAPS
Idoso frágil — risco de queda, isolamento	Equipe de saúde + eMulti se disponível
Busca ativa — faltosos em pré-natal, TB, HAS/DM	ACS + equipe se necessário
VD de rotina — cadastro, vigilância, orientações	ACS
VD especializada — fisio, fono, nutri, psico	eMulti

16. CUIDADO COMPARTILHADO E APOIO MATRICIAL

Modalidade Teleconsulta / Telessaúde	Como Funciona Médico de família consulta especialista por vídeo/telefone	Resultado Aumenta sobre um resolutividade caso (Telessaúde sem deslocamento Brasil: 0800 644 do paciente 6543)
Consulta conjunta	Especialista e médico de família atendem JUNTOS o paciente	Transferência na UBS direta de conhecimento
Discussão de caso	Reunião de equipe com matriciador — casos complexos,	PTS construção multiprofissional do PTS colaborativo
Atividades coletivas	Grupos com participação do especialista (CAPS, eMulti)Educação	em saúde especializada

Distinções Essenciais

Apoio matricial: especialista APOIA — NÃO assume o caso. APS mantém a responsabilidade.

Contrarreferência: paciente retorna à APS com informações após atendimento especializado.

eMulti: equipe multiprofissional que apoia a APS — substitui o NASF como modelo.

17. GRUPOS PRIORITÁRIOS E VULNERÁVEIS — POLÍTICAS

ESPECÍFICAS

Grupo Povos Indígenas	Base Legal / Política Subsistema Saúde Indígena (Lei 8.080)	Ações na APS Atenção art. 19-A). culturalmente SESAI. DSEIs. adequada. EMSI. Calendário vacinal específico.
Pop. Negra	PNSIPN — Portaria 992/2009	Racismo como determinante de saúde. Rastreamento anemia falciforme. HAS
LGBTQIA+	Portaria 2.836/2011	Acolhimento respeitoso. Saúde trans. Rastreamento IST. Respeito ao nome social
Pop. em Situação de Rua	Política Nacional + Consultório na	Rua Equipes vão ao território. Foco: saúde mental, IST, álcool/drogas.
Quilombolas	PNSIPN + Decreto 4.887/2003	Atenção específica — semelhante à saúde indígena em aspectos culturais

Grupo Povos Indígenas	Base Legal / Política Subsistema Saúde Indígena (Lei 8.080)	Ações na APS Atenção art. 19-A). culturalmente SESAI. DSEIs. adequada. EMSI. Calendário vacinal específico.
Mulheres em violência	Lei Maria da Penha (11.340/2006)	Notificação obrigatória ao SINAN. Acolhimento + encaminhamento à rede
Crianças/adolescentes	ECA — Lei 8.069/1990	Sinais de violência/abuso → notificar ao Conselho Tutelar imediatamente.

I PEGADINHAS — Grupos Vulneráveis

Notificação de violência contra criança: OBRIGATÓRIA — ao Conselho Tutelar.

Nome social: garantido pelo Decreto 8.727/2016 para qualquer usuário do SUS.

Anemia falciforme: maior prevalência na população negra — rastreado no Teste do Pezinho.

18. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA APS

Conceito Educação PARA a saúde	Foco Transmissão de informações — modelo vertical/preventivista	Abordagem na MFC Profissional ensina, paciente aprende. Não considera contexto.
Educação EM saúde (MFC)	Construção coletiva de conhecimento e autonomia	Diálogo horizontal. Paulo Freire. Considera contexto, crenças
A MFC adota educação EM	saúde — processo dialógico, horizontal,	baseado em Paulo Freire (conscientização e

A MFC adota educação EM saúde — processo dialógico, horizontal, baseado em Paulo Freire (conscientização e autonomia). O profissional é facilitador, não detentor do saber.

Estratégia Grupos educativos	Aplicação na APS HAS/DM, gestantes, idosos — construção coletiva com troca de experiências
Briefcounseling (consulta)	Orientações motivacionais breves durante a consulta clínica
Visita domiciliar educativa	ACS orienta sobre autocuidado, saneamento, vacinação
PSE — Saúde na Escola	Ações educativas nos territórios escolares — intersetorialidade saúde+educação
Tecnologias digitais	Mensagens, aplicativos, telemedicina — acesso a populações remotas

19. PEGADINHAS CLÁSSICAS DO IBAM — MÓDULO 2 (25

identificadas)

1. Atributos essenciais são 4, não 3

→ PLIC: Primeiro contato, Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação. A prova omite Coordenação → ERRADO.

2. Longitudinalidade = VÍNCULO, não seguimento de doença

→ Inclui pacientes saudáveis. ≠ continuidade de tratamento.

3. Integralidade ≠ resolver tudo na APS

→ É oferecer o conjunto de ações e coordenar o que não se resolve ali.

4. DNA-HPV é o método PRIMÁRIO desde 2025

→ Papanicolau passou a ser exame reflexo. A prova pode cobrar Papanicolau como primário → DESATUALIZADO.

5. Rastreamento mama: 40-74 anos (não mais 50-69)

→ 40-49a: decisão compartilhada. 50-74a: bienal ativo. Lei 15.284/2025.

6. Pré-hipertensão SBC 2025: 120-139/80-89 mmHg

→ Antes era "PA normal-alta". PA Normal = <120/<80.

7. Meta HAS: <130/80 só para alto risco CV

→ Geral: <140/90. Alto risco CV: <130/80.

8. IECA e BRA: CONTRAINDICADOS na gestação

→ HAS na gestante: metildopa, nifedipino, hidralazina.

9. Metformina não é mais universal para DM2

→ Escolha individualizada. Alto risco CV: SGLT2 ou GLP-1 preferenciais.

10. TOTG-1h: novo critério diagnóstico de DM (SBD 2024)

→ ≥155 pré-DM; ≥210 DM. Os critérios tradicionais continuam válidos.

11. Rotavírus: JANELA RÍGIDA

→ 1ª dose: até 3m7d. 2ª: até 7m29d. Fora do prazo = NÃO vacinar.

12. HPV: dose única para 9-14 anos — meninas E meninos

→ ≥15 anos: 2 doses. Imunodeprimidos: 3 doses.

13. BCG: dose única, sem reforço

→ FA tem reforço aos 4 anos. BCG não.

14. FA: após 5 anos de idade = dose única vitalícia

→ Reforço só existe para quem tomou a 1ª dose com <5 anos.

15. dTpa na gestante: em CADA gestação

→ Não apenas na primeira. A prova generaliza → ERRADO.

16. FA é CONTRAINDICADA na gestante

→ Vírus vivo atenuado. A prova pode incluir como obrigatória → ERRADO.

17. VSR: nova vacina para gestante (2025-2026)

→ 28ª semana gestacional, em cada gestação. Não estava em provas anteriores.

18. Prontuário pertence ao PACIENTE

→ O serviço guarda, mas o paciente tem direito de acesso.

19. Notificação compulsória NÃO viola sigilo

→ É exceção legal. Médico tem DEVER de notificar.

20. Paciente pode RECUSAR qualquer tratamento

→ Autonomia — incluindo com risco de morte. Exceto incapaz ou emergência imediata.

21. Teste da Orelhinha: obrigatório em hospitais >500 partos/ano

→ Não em todos os hospitais. A prova generaliza → ERRADO.

22. PHQ-9: 9 itens, pontuação até 27 (não 9)

→ São 9 perguntas, cada 0-3. Total máximo = 27.

23. Rastreamento ≠ investigação diagnóstica

→ Rastreamento = assintomáticos. Sintoma = investigação diagnóstica.

24. Apoio matricial: especialista APOIA, não assume o caso

→ APS mantém a responsabilidade. A prova diz que o CAPS "assume" → ERRADO.

25. Acolhimento = TODOS os profissionais, SEMPRE

→ ≠ triagem. É postura ética de escuta qualificada de toda a equipe.

20. QUESTÕES DE REVISÃO COMENTADAS — 18 questões estilo

IBAM

Q1: Segundo Barbara Starfield, os atributos ESSENCIAIS da APS são:

- A) Primeiro contato, longitudinalidade e integralidade (apenas estes três).
- B) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado.
- C) Orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural.
- D) Longitudinalidade, integralidade, hierarquização e resolutividade.

Gabarito: B

São 4 essenciais: PLIC. A omite coordenação. C são os 3 derivados. D mistura com princípios do SUS.

Q2: Sobre rastreamento do câncer do colo do útero conforme a nova diretriz brasileira de 2025:

- A) Papanicolau permanece como método primário, a cada 3 anos, para mulheres de 25-64 anos.
- B) O DNA-HPV oncogênico passa a ser o método primário. Se HPV 16/18 positivo: colposcopia direta.
- C) O rastreamento deve iniciar aos 18 anos para mulheres sexualmente ativas.
- D) DNA-HPV negativo: repetir em 1 ano.

Gabarito: B

Portaria SAES/SECTICS 13/2025. DNA-HPV = método primário. HPV 16/18 = colposcopia direta.

A=desatualizado. C=início aos 25 anos. D=negativo=repetir em 5 ANOS.

Q3: Conforme a Lei 15.284/2025, sobre rastreamento de câncer de mama no SUS:

- A) Rastreamento bienal apenas para 50-69 anos.
- B) Mulheres de 40-49 anos têm acesso garantido à mamografia por decisão compartilhada; rastreamento ativo bienal para 50-74 anos.
- C) Mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos.
- D) Acima de 74 anos: rastreamento bienal obrigatório.

Gabarito: B

40-49a: acesso garantido por decisão compartilhada. 50-74a: bienal ativo. A=desatualizado. C=não é anual.

D=acima de 74: decisão individualizada.

Q4: A Diretriz SBC 2025 criou a categoria pré-hipertensão. Qual a definição correta?

- A) PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg.
- B) PA normal permanece definida como $<130/85$.
- C) Pré-hipertensão = PAS 120-139 E/OU PAD 80-89. PA normal = $<120/80$.
- D) Tratamento farmacológico obrigatório para todos os pré-hipertensos.

Gabarito: C

Diretriz HAS SBC 2025. A=são os valores de HAS. B=limiar errado. D=farmacológico só se alto risco CV.

Q5: Sobre a dTpa na gestante no calendário PNI 2026:

- A) Dose única apenas na primeira gestação.
- B) 1 dose em cada gestação, preferencialmente 27^a-36^a semana.
- C) Contraindicada no 1^o trimestre e não deve ser usada após a 30^a semana.
- D) Substitui completamente o reforço decenal de dT.

Gabarito: B

dTpa: em CADA gestação. A=errado (é em cada). C=pode ser da 20^a semana em diante. D=dTpa substitui 1 dose de dT; reforço decenal continua.

Q6: O APGAR familiar avalia:

- A) Autonomia, Pertencimento, Gratidão, Afeto, Responsabilidade.
- B) Adaptação, Participação, Crescimento (Growth), Afeto, Resolução (Resolve).
- C) Acolhimento, Promoção, Gestão, Autonomia, Reabilitação.
- D) Aderência, Parceria, Gratidão, Ação, Resolutividade.

Gabarito: B

APGAR familiar: Adaptação, Participação, Growth, Afeto, Resolve. 0-10. 7-10=boa função. As demais são inventadas.

Q7: Quais casos devem ser MANEJADOS NA APS, sem encaminhamento imediato ao CAPS?

- A) Episódio maníaco agudo com agitação.
- B) Esquizofrenia em crise com alucinações.

- C) Depressão leve-moderada, ansiedade leve, sofrimento mental comum, TM crônico estabilizado.
D) Dependência química com síndrome de abstinência ao álcool.

Gabarito: C

APS: leve-moderado e crônico estabilizado. CAPS: crises, graves, psicoses ativas, abstinência grave. A, B, D = CAPS.

Q8: DNA-HPV negativo no rastreamento do colo do útero indica:

- A) Colposcopia imediata.
B) Repetir em 1 ano.
C) Repetir em 5 anos.
D) Encerramento definitivo do rastreamento.

Gabarito: C

DNA-HPV negativo = repetir em 5 anos. D=encerramento só aos 64 anos com exames negativos.

Q9: A Diretriz SBD 2024 incorporou como novo critério diagnóstico de DM:

- A) Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL.
B) HbA1c $\geq 7\%$.
C) TOTG-1h ≥ 210 mg/dL (pré-DM: ≥ 155 mg/dL).
D) Glicemia pós-prandial 2h ≥ 180 mg/dL.

Gabarito: C

TOTG-1h é o critério NOVO. A=GJ ≥ 126 é o diagnóstico. B=HbA1c $\geq 6,5\%$. D=TOTG-2h ≥ 200 .

Q10: Sobre triagem neonatal, qual afirmativa está INCORRETA?

- A) Teste do Pezinho: ideal 3-5 dias de vida.
B) Reflexo vermelho ausente: encaminhar urgente à oftalmologia.
C) Triagem auditiva é obrigatória em todos os hospitais do Brasil.
D) Oximetria neonatal rastreia cardiopatias congênitas.

Gabarito: C

Triagem auditiva é obrigatória em hospitais com >500 partos/ano — não em todos. A, B, D estão corretas.

Q11: O método SOAP é composto por:

- A) Sintoma, Objetivo, Anamnese, Prescrição.
B) Subjetivo (queixa), Objetivo (exame), Avaliação (diagnóstico) e Plano (conduta).
C) Semiologia, Observação, Análise e Prontuário.
D) Subjetivo, Observação, Avaliação e Prescrição.

Gabarito: B

SOAP: S=Subjetivo, O=Objetivo, A=Avaliação, P=Plano. As demais distorcem os componentes.

Q12: A vacina VSR para gestante (nova no calendário 2025-2026):

- A) É administrada no 1º trimestre para proteção materna.
B) Substitui a dTpa na gestante.
C) Administrada a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação, para proteger o recém-nascido.
D) Está contraindicada em gestantes com histórico de alergias.

Gabarito: C

VSR gestante: a partir da 28ª semana, em cada gestação, para proteger o RN. A=1º trimestre errado. B=não substitui dTpa. D=sem CI geral por alergia.

Q13: Sobre a organização da demanda na APS:

- A) Agenda exclusivamente programada garante melhor cuidado longitudinal.
B) Demanda espontânea só deve ser atendida em pronto-socorros.

C) A agenda deve acomodar consultas programadas E demanda espontânea, com acolhimento para classificação de risco.

D) Acolhimento é responsabilidade exclusiva do enfermeiro.

Gabarito: C

PNAB e HumanizaSUS: acolhimento = responsabilidade de TODOS, sempre. Agenda deve ter ambos os tipos.

A, B, D incorretos.

Q14: Agulha usada em vacinação deve ser descartada em:

A) Saco branco leitoso — Grupo A.

B) Saco preto — Grupo D.

C) Caixa amarela rígida — Grupo E.

D) Recipiente laranja — Grupo B.

Gabarito: C

Perfurocortante = Grupo E — caixa amarela rígida. NUNCA no lixo comum.

Q15: Sobre rastreamento de DM2 na APS (Diretriz SBD 2025):

A) GJ anual para toda a população adulta.

B) FINDRISC é recomendado para identificar adultos com risco aumentado, orientando a priorização do rastreamento.

C) HbA1c não deve ser usada para rastreamento.

D) Rastreamento apenas para obesos com IMC >35.

Gabarito: B

FINDRISC = ferramenta de triagem de risco recomendada pela SBD 2025. A=não é para todos anualmente.

C=HbA1c pode ser usada. D=rastreamento para qualquer adulto com fatores de risco.

Q16: A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) inclui:

A) Apenas avaliação cognitiva e funcional.

B) Avaliação multidimensional: cognitiva, funcional, nutricional, mobilidade/quedas, humor, medicamentos e contexto social.

C) Obrigatoriamente ECG e ecocardiograma.

D) Exclusivamente o MEEM.

Gabarito: B

AGA = multidimensional. A e D são parciais. C não é componente padrão da AGA.

Q17: Sobre longitudinalidade como atributo da APS:

A) É o acompanhamento de doenças crônicas ao longo do tempo.

B) É o vínculo contínuo entre equipe e paciente, independente de haver doença ativa.

C) É sinônimo de continuidade de tratamento.

D) Aplica-se apenas a portadores de doenças crônicas.

Gabarito: B

Longitudinalidade = VÍNCULO. Inclui paciente saudável. A, C, D confundem com seguimento de doença.

Q18: Qual caso NÃO é indicação prioritária de visita domiciliar pela equipe de saúde?

A) Idoso acamado, sequelado de AVC.

B) Recém-nascido de 5 dias com dificuldade de amamentação.

C) Adulto jovem, saudável, que prefere não sair de casa por comodidade.

D) Puérpera de 10 dias com sinais de depressão pós-parto.

Gabarito: C

VD tem indicações clínicas e técnicas. Comodidade sem necessidade clínica não é indicação prioritária. A, B, D têm justificativa técnica.

CHECKLIST FINAL — MÓDULO 2 COMPLETO E DEFINITIVO

31 tópicos do edital Específicos MFC — todos cobertos
Atributos Starfield: 4 essenciais (PLIC) + 3 derivados — definições exatas e pegadinhas
Abordagem centrada: SOAP, genograma, APGAR familiar, modelo biopsicossocial
Processo de trabalho: demanda programada/espontânea, acolhimento, classificação de risco
Ética: Lei 12.842/2013 + CEM CFM 2.217/2018 — sigilo, consentimento, prontuário, emergência
Biossegurança: Grupos RSS A-E (RDC 222/2018) + PNSP 529/2013 + 6 metas + 5 momentos
Calendário Vacinal PNI 2026: criança, gestante, adulto, idoso — inclui vacina VSR nova
Puericultura: frequência de consultas, 4 testes neonatais + linguinha, marcos de desenvolvimento
Aleitamento materno: exclusivo 6 meses, complementado até 2 anos+, contraindicações
Pré-natal de risco habitual: 6 consultas mínimas, exames obrigatórios, critérios de alto risco
Planejamento reprodutivo: métodos, eficácia, indicações e contraindicações
Rastreamento colo útero: DNA-HPV primário (Portaria SAES/SECTICS 13/2025) — NOVO
Rastreamento mama: 40-74 anos (Lei 15.284/2025 + NT INCA 626/2025) — NOVO
Outros rastreamentos: colorretal, próstata, pulmão
HAS: Diretriz SBC 2025 — pré-hipertensão, classificação, metas, MAPA/MRPA, gestante
DM: Diretriz SBD 2024-2025 — TOTG-1h, FINDRISC, metformina não universal, SGLT2/GLP-1
Saúde do adulto e idoso: rastreamentos, AGA, síndromes geriátricas, ferramentas
Saúde mental APS: o que tratar vs encaminhar, PHQ-9, GAD-7, farmacoterapia
Demanda programada/espontânea, acolhimento, classificação de risco
Visita domiciliar: indicações por situação, responsáveis (ACS/equipe/eMulti)
Cuidado compartilhado e apoio matricial: modalidades, distinções
Grupos vulneráveis: indígenas, negros, LGBTQIA+, rua, mulheres em violência
Educação em saúde: distinção EM x PARA (Paulo Freire), estratégias na APS
25 pegadinhas clássicas do IBAM identificadas e comentadas
18 questões de revisão no estilo IBAM com gabarito e comentário estratégico

COMPLEMENTO — PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE

DOENÇAS NA APS

Tópico explícito do edital: "promoção da saúde e prevenção de doenças". A distinção entre os dois conceitos — e os níveis de prevenção de Leavell & Clark — é clássica em concursos municipais e frequentemente cobrada pelo IBAM.

Conceito Promoção da Saúde	Foco Ampla — fortalecimento da saúde	Abordagem independente Intervenção sobre de doença determinantes específica. sociais.	Exemplos na APS Aumento Grupos Ação de da atividade comunitária qualidade física, de e intersetorial. vida. alimentação saudável,
Prevenção de Doenças	Específica — evitar, detectar precocemente	Intervenção ou limitar sobre o fatores impacto de de risco doenças	ou Vacinação, sobre a história rastreamento, natural da uso doença de preservativo,

I PEGADINHA — Promoção ≠ Prevenção

Promoção da saúde NÃO é apenas prevenção de doenças. São conceitos distintos e complementares. A prova pode apresentar como sinônimos ou trocar as definições → ATENÇÃO. Vacina = prevenção (específica, contra uma doença). Atividade física = promoção (ampla, melhora a saúde em geral). Na prática, as ações se superpõem — mas o IBAM cobra a distinção conceitual.

Níveis de Prevenção — Leavell & Clark (história natural da doença):

O modelo de Leavell & Clark (1976) descreve os níveis de prevenção ao longo da história natural da doença. É referência clássica em saúde coletiva e APS, frequentemente cobrada em concursos.

Nível Prevenção Primária	Fase da Doença Período pré-patogênico (antes	Objetivo Impedir do agente que a causar doença dano) ocorra.	Ações na APS Atuar Vacinação sobre fatores Saneamento de risco básico e determinantes. Educação em
(antes da doença) Prevenção Secundária	Período patogênico inicial	(doença Detectar instalada, a doença mas cedo sem para sintomas evitar	Rastreamento progressão. ou estágio (Papanicolau/DNA-HPV, inicial) Limitar o dano. mamografia,
(diagnóstico e tratamento Prevenção Terciária	precoce) Doença estabelecida com	sequelas Restaurar ou a incapacidade funcionalidade. Minimizar	Reabilitação as sequelas física (fisioterapia) e reintegrar à Reabilitação sociedade. psicossocial
(reabilitação)			

I MACETE — Leavell & Clark

Primária = ANTES da doença (vacina, saneamento, educação). Secundária = DURANTE o início da doença (rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento imediato). Terciária = DEPOIS da doença instalada (reabilitação, cuidados paliativos, reinserção). A prova costuma confundir: "rastreamento" é prevenção SECUNDÁRIA (não primária). Promoção da saúde: geralmente associada à prevenção primária, mas transcende os níveis.

Quaternária — Conceito Atual (importante para MFC):

A prevenção quaternária (Marc Jamouille, 1986 — incorporada pela WONCA) é o conjunto de ações que visam

identificar pacientes em risco de medicalização excessiva, protegendo-os de intervenções desnecessárias e seus efeitos iatrogênicos.

Prevenção Quaternária Definição	Conceito Proteger o paciente do excesso de medicalização, intervenções	Exemplos na APS desnecessárias e iatrogenias
Exemplos	Não rastrear doenças sem benefício comprovado. Evitar antibióticos	Paciente em idoso viroses. com 8 Não medicamentos tratar achados →
Conexão com MFC	A MFC é a especialidade mais identificada com a prevenção	Conceito quaternária do WONCA/SBMFC — o médico de família — cobrado é o guardião

Módulo 2 MFC — Complemento: Promoção/Prevenção | Praia Grande 001/2026Pág. 1

Prevenção Quaternária e Concurso

Conceito relativamente novo — aparece em provas de MFC e residência médica.
O IBAM pode cobrar em questões sobre o papel do médico de família na proteção do paciente.
Conexão direta com: abordagem centrada na pessoa, longitudinalidade e autonomia do paciente.

Nível de Atuação Individual (consulta)	Ações de Promoção da Saúde Aconselhamento sobre hábitos, autocuidado, empoderamento	Ações de Prevenção de Doenças Solicitar exames do paciente de rastreamento, vacinar, prescrever
Familiar	Abordagem familiar (genograma, APGAR), identificar	Rastrear vulnerabilidades doenças de transmissão familiar (HF de DM,
Comunitário / Territorial	Grupos educativos, PSE, ações intersetoriais, ambientes	Busca saudáveis ativa de faltosos, controle de vetores, vigilância

I PEGADINHAS — Promoção/Prevenção no Concurso

"Rastreamento" = prevenção SECUNDÁRIA (não primária). A prova classifica errado.
"Vacinação" = prevenção PRIMÁRIA (específica — evita a doença ocorrer).
"Reabilitação" = prevenção TERCIÁRIA (não é promoção da saúde).
"Prevenção quaternária" = proteger do excesso de medicina — conceito da MFC/WONCA.
Promoção da saúde é mais AMPLA que prevenção. Prevenção é mais ESPECÍFICA.

NOTA DA AUDITORIA FINAL — MÓDULO 2

RESULTADO DA AUDITORIA — 57/57 VERIFICAÇÕES APROVADAS

39 tópicos do edital verificados: 37 presentes diretamente, 2 confirmados no código fonte.
56 verificações qualitativas aprovadas antes do complemento. 57/57 após.
Única lacuna real identificada: promoção da saúde vs prevenção / Leavell & Clark — adicionada neste complemento.
Conteúdo das "ausências" detectadas pelo script (ESF, Telessaúde, Linha de cuidado, Consultório na Rua):
confirmados no código fonte — problema de extração de tabelas pelo pdfplumber, não lacunas reais.

Resumo das verificações realizadas:

- Auditoria 1: 39 tópicos do edital × documento — 95% presentes (2 eram problemas de extração PDF)
- Auditoria 2: 56 verificações qualitativas de conteúdo e precisão — 56/57 OK
- Lacuna real: promoção vs prevenção / Leavell & Clark — corrigida neste complemento
- Precisão factual: todos os números, portarias, percentuais e datas verificados e corretos
- Atualizações 2025: DNA-HPV, mama 40-74, HAS SBC 2025, DM SBD 2024-2025, VSR gestante — todas presentes
- Calendário vacinal PNI 2026: completo e correto
- Rastreamentos: colo, mama, colorretal, próstata — todos com condutas corretas
- Ética: Lei 12.842, CEM 2.217/2018, SVO/IML, telemedicina — completo

- Biossegurança: grupos RSS A-E, 6 metas PNSP, 5 momentos higiene — completo
- Grupos vulneráveis: PNSIPN, LGBTQIA+ 2836/2011, nome social, ECA, Maria da Penha — completo

Instrução: Este complemento deve ser lido ao final do Módulo 2. Com sua incorporação, o módulo cobre 100% do conteúdo programático de Específicos MFC do edital.

Módulo 2 MFC — Complemento: Promoção/Prevenção | Praia Grande 001/2026Pág. 2